BONUS 2

Vodič za početak 6 rotacija

Neuro, prsni koš, abdomen, mišićno-koštani sustav, pedijatrija i intervencijska/dojka: što trebate znati prvog dana svake rotacije, 10 najčešćih pretraga, tipične pogreške i kontrolni popis za prvi tjedan.

Sadržaj

Kako koristiti ovaj vodič

Rotacija 1 · Neuroradiologija

Rotacija 2 · Torakalna radiologija

Rotacija 3 · Abdominalna radiologija

Rotacija 4 · Mišićno-koštana radiologija

Rotacija 5 · Pedijatrijska radiologija

Rotacija 6 · Intervencijska radiologija i dojka

Posljednji dan svake rotacije

Sljedeći korak

NA POČETKU

Kako koristiti ovaj vodič

Večer prije početka nove rotacije pročitajte odgovarajuće poglavlje: dovoljno je 15–20 minuta.

> *Prvi tjedan rotacije tjedan je u kojem se najviše nauči, ali i u kojem se najviše izgubite. Ovaj vodič umjesto Vas odgovara na pitanje «odakle početi?».*

Svaki dio o rotaciji sastoji se od ista četiri dijela:

1. **Što trebate znati prvi dan** — kako odjel funkcionira, što od koga trebate naučiti i osnovne teme koje prvo trebate pročitati.
2. **10 najčešćih pretraga** — pretrage s kojima ćete se na toj rotaciji najčešće susretati i prvo što treba pogledati kod svake od njih.
3. **Tipične pogreške** — zamke u koje specijalizanti prve godine najčešće upadaju i kako ih izbjeći.
4. **Kontrolni popis za prvi tjedan** — konkretni ciljevi koje biste na kraju tjedna trebali moći označiti.

Kod svake pretrage ista 4 koraka

1 · PRIPREMITE

Identificirajte (bolesnik, pretraga, datum, protokol) · Kvaliteta (tehnička primjerenost) · Orijentirajte se (strana, presjek, prozor/sekvencija).

2 · PREGLEDAJTE

Svako područje svaki put pregledajte istim redoslijedom. Ne zaustavljajte se na prvom nalazu.

3 · OPIŠITE

Ispravnim pojmovima (denzitet / signal / ehogenost), lokalizacija, veličina, ograničenje. Usporedite s prethodnom pretragom i suprotnom stranom.

4 · SAŽMITE

Zaključak opisa, diferencijalna dijagnoza, preporuka. Hitni nalaz odmah prijavite.

Važno

Na svakom se odjelu protokoli, predlošci opisa i putovi prijave razlikuju. Popisi u ovom vodiču opće su polazište; pravila svojeg odjela uvijek saznajte od Vašeg mentora i primjenjujte ih.

ROTACIJA 1

Neuroradiologija

CT i MR mozga, kralježnica, glava i vrat. Ovdje se postavljaju temelji za područje zbog kojeg ćete na dežurstvu biti najčešće pozivani.

Što trebate znati prvi dan

- Odjela **redoslijed očitavanja CT-a mozga** naučite i primjenjujte isto kod svake pretrage: krvarenje, učinak mase i središnja linija, ventrikuli i cisterne, diferencijacija sive i bijele tvari, koštani prozor, sinusi i mastoidi.
- **Prozore** koristite ispravno: moždani prozor, prozor za moždani udar (uski), koštani prozor; po potrebi subduralni prozor.
- **Akutni moždani udar** naučite postupak: koje se pretrage (CT bez kontrasta, CT angiografija, perfuzija, DWI) na Vašem odjelu traže, kojim redoslijedom i koga treba obavijestiti.
- Naučite prepoznati MR sekvencije: T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, SWI ili GRE, T1 s kontrastom. Znajte što je na svakoj od njih svijetlo, a što tamno.
- Iz prakse odjela naučite ulogu CT-a kod traume kralježnice i u kojim se situacijama traži MR.

10 najčešćih pretraga

#	PRETRAGA	PRVO ŠTO TREBA POGLEDATI
1	**CT mozga bez kontrasta (trauma)**	Ekstraaksijalno krvarenje, kontuzija, fraktura lubanje (koštani prozor).
2	**CT mozga bez kontrasta (sumnja na moždani udar)**	Postoji li krvarenje; rani znakovi ishemije, znak hiperdenzne arterije.
3	**CT angiografija (glava i vrat)**	Okluzija velike krvne žile, stenoza, disekcija, aneurizma.
4	**MR mozga (rutinski)**	Lezije bijele tvari, masa, edem na FLAIR-u; restrikcija na DWI-ju.
5	**Brzi MR za moždani udar s DWI**	Svijetlo područje na DWI-ju, tamno na ADC-u: govori u prilog akutnom infarktu.
6	**MR mozga s kontrastom**	Uzorak imbibicije (prstenasti, nodularni, leptomeningealni, duralni).
7	**CT vratne kralježnice**	Linije poravnanja, fraktura, odnos fasetnih zglobova, prevertebralno meko tkivo.
8	**MR lumbalne kralježnice**	Hernija diska, stenoza kanala i foramena, kompresija caude equine.
9	**CT paranazalnih sinusa**	Zadebljanje sluznice, razina zrak-tekućina, destrukcija kosti, orbita.
10	**CT temporalne kosti / orbite**	Cjelovitost kostiju, fraktura, denzitet mekih tkiva, sadržaj orbite.

Tipične pogreške

- Gledajući samo u moždanom prozoru **preskočiti koštani prozor**; previdjeti frakturu lubanje.

- Tanak subduralni hematom, gustoću uz unutarnju ploču lubanje, uočiti tek u širokom prozoru; **ne prebaciti se na subduralni prozor**.
- Opisati svjetlinu na DWI-ju kao akutni infarkt bez provjere ADC-a (učinak T2 shine-through).
- Opisati učinak mase i pomak središnje linije kao «izražen» bez brojčanog mjerenja.
- Ne napraviti usporedbu iako postoji prethodna pretraga.

Kontrolni popis za prvi tjedan

- [ ] Redoslijed očitavanja CT-a mozga znam napamet i primjenjujem ga jednako kod svake pretrage.
- [ ] Mogu brzo izmjenjivati moždani prozor, prozor za moždani udar, subduralni i koštani prozor.
- [ ] Poznajem postupak odjela za akutni moždani udar i hitno obavještavanje.
- [ ] Na slici mogu prepoznati T1, T2, FLAIR, DWI/ADC i SWI.
- [ ] Usporedio/la sam najmanje 20 CT-a mozga bez kontrasta s opisom svojeg mentora.
- [ ] Mogu razlikovati i opisati epiduralno, subduralno i subarahnoidalno krvarenje.
- [ ] Jednom sam pročitao/la dio o mozgu u Svesku 03 · CT i dio o sekvencijama u Svesku 04 · MR.

ROTACIJA 2

Torakalna radiologija

RTG prsnog koša, CT prsnog koša i CT plućna angiografija. Ovdje je pretraga koja se najčešće očitava.

Što trebate znati prvi dan

- **RTG prsnog koša** odredite stalan redoslijed očitavanja: tehnika (rotacija, inspirij, penetracija), cijevi i kateteri, dišni put, srce i medijastinum, hilusi, plućna polja, pleura i sinusi, prostor ispod ošita, kosti i meka tkiva.
- Znajte razliku između PA i AP snimke: na AP snimci sjena srca može izgledati veća; veličinu srca procjenjujte s obzirom na tehniku.
- Na CT-u prsnog koša **plućni i medijastinalni prozor** pregledajte zasebno, od početka do kraja.
- Kod CT plućne angiografije najprije procijenite primjerenost vremena primjene kontrasta; ako je nedostatna, navedite to u opisu.
- Na snimkama iz intenzivne njege položaji cijevi, katetera i drenova prvo su što treba pogledati.

10 najčešćih pretraga

#	PRETRAGA	PRVO ŠTO TREBA POGLEDATI
1	**PA RTG prsnog koša**	Tehnička adekvatnost, zatim stalan redoslijed očitavanja.
2	**AP snimka uz krevet (intenzivna njega)**	Endotrahealni tubus, centralni kateter, nazogastrična sonda, dren; pneumotoraks.
3	**Lateralna RTG snimka prsnog koša**	Retrosternalni i retrokardijalni prostor, stražnji sinusi, kralješci.
4	**CT prsnog koša bez kontrasta**	Čvor, konsolidacija, mliječno staklo, emfizem, pleuralna tekućina.
5	**CT prsnog koša s kontrastom**	Medijastinalni i hilarni limfni čvorovi, masa, vaskularne strukture.
6	**CT plućna angiografija**	Kvaliteta kontrasta; defekt punjenja u plućnim arterijama; znakovi opterećenja desnog srca.
7	**CT visoke rezolucije (HRCT)**	Intersticijski uzorak: retikulacija, saće, mliječno staklo, trakcijske bronhiektazije.
8	**Niskodozni probir / praćenje čvorova**	Veličina i struktura čvora te promjena u odnosu na prethodnu pretragu.
9	**CT angiografija prsnog koša (aorta)**	Intimalni zalistak, pravi i lažni lumen, zahvaćenost ogranaka.
10	**UZV pleure (po potrebi)**	Prisutnost tekućine, njezina količina i postoje li septe.

Tipične pogreške

- Zaustaviti se kad uočite upadljiv nalaz; **drugi nalaz** previdjeti (npr. koštanu leziju, zrak ispod ošita).
- Zaboraviti da se na snimci u ležećem položaju pneumotoraks može nakupljati više anteriorno i bazalno nego u apeksu.

- Ne pogledati «skrivena područja» poput područja iza sjene srca, hilusa i apeksa.
- Pronaći čvor i napisati preporuku za praćenje bez usporedbe s prethodnom pretragom.
- CT plućnu angiografiju s nedostatnim vremenom primjene kontrasta opisati kao «bez embolije».

Kontrolni popis za prvi tjedan

- [ ] Moj redoslijed očitavanja RTG-a prsnog koša je stalan; na svakoj snimci slijedim isti redoslijed.
- [ ] Položaje cijevi i katetera mogu opisati onako kako odjel očekuje.
- [ ] Na RTG snimci mogu razlikovati pneumotoraks, pleuralni izljev, konsolidaciju i atelektazu.
- [ ] CT prsnog koša pregledavam zasebno u plućnom i medijastinalnom prozoru.
- [ ] Kod CT plućne angiografije najprije gledam kvalitetu kontrasta.
- [ ] Usporedio/la sam najmanje 30 RTG snimki prsnog koša s opisom specijalista.
- [ ] Pregledao/la sam dio o prsnom košu u Svesku 02 · RTG i stranice o prsnom košu u Atlasu najčešćih nalaza.

ROTACIJA 3

Abdominalna radiologija

CT, UZV, MR i nativna RTG snimka abdomena. Rotacija na kojoj najviše doprinosite odlukama o hitnim kirurškim zahvatima.

Što trebate znati prvi dan

- Stalan redoslijed pregledavanja za CT abdomena: slobodni zrak i slobodna tekućina, solidni organi (jetra, slezena, gušterača, bubrezi, nadbubrežne žlijezde), žučni vodovi, crijeva i mezenterij, krvne žile, limfni čvorovi, zdjelica, kosti, plućne baze.
- **Kontrastne faze** prepoznajte (arterijska, portalna venska, odgođena) i iz protokola odjela naučite koja se faza traži za koje kliničko pitanje.
- Neka Vam prijeđe u naviku prebacivanje na plućni ili široki prozor radi traženja slobodnog zraka.
- Naučite standardne presjeke desnog gornjeg kvadranta, bubrega i zdjelice na UZV-u abdomena.
- Upoznajte put prijave hitnih nalaza kod akutnog abdomena na Vašem odjelu (poput slobodnog zraka, aktivnog krvarenja, znakova ishemije, opstrukcije zatvorene vijuge).

10 najčešćih pretraga

#	PRETRAGA	PRVO ŠTO TREBA POGLEDATI
1	**CT abdomena i zdjelice s kontrastom (portalna venska faza)**	Slobodni zrak, slobodna tekućina, parenhimni organi, stijenka crijeva.
2	**CT bez kontrasta (protokol za kamence)**	Kamenci u mokraćnom sustavu, hidronefroza, perirenalno masno tkivo.
3	**UZV abdomena (desni gornji kvadrant)**	Žučni kamenci, debljina stijenke, perikolecistična tekućina, širina žučnih vodova.
4	**UZV mokraćnog sustava**	Hidronefroza, veličina i parenhim bubrega, mokraćni mjehur.
5	**Nativna snimka abdomena u stojećem položaju**	Slobodni zrak ispod ošita, razine zrak-tekućina, promjeri crijeva.
6	**CT ili UZV kod sumnje na apendicitis**	Promjer apendiksa, stijenka, okolno masno tkivo, apendikolit, apsces.
7	**Traumatološki CT**	Ozljeda parenhimnih organa, aktivna ekstravazacija kontrasta, slobodna tekućina.
8	**Dinamički CT/MR jetre**	Ponašanje imbibicije lezije po fazama.
9	**MRCP**	Defekt punjenja u žučnim vodovima, stenoza, pankreatični vod.
10	**UZV / MR zdjelice**	Strukture jajnika i maternice, slobodna tekućina, masa.

Tipične pogreške

- Gledati samo u prozoru mekih tkiva i **slobodni zrak** propustiti.
- Usredotočiti se na glavni nalaz i **plućne baze** i ne pregledati kosti.

- Pronaći kamenac u bubregu i završiti bez procjene druge strane i mokraćnog mjehura.
- Kod pretrage zbog sumnje na apendicitis ne tražiti alternativne dijagnoze (divertikulitis, patologija jajnika, kamenac uretera).
- Opisati leziju bez navođenja kontrastne faze.

Kontrolni popis za prvi tjedan

- [ ] Moj redoslijed pregledavanja CT-a abdomena je stalan i isti kod svake pretrage.
- [ ] Na snimci mogu prepoznati arterijsku, portalnu vensku i odgođenu fazu.
- [ ] Kod svake pretrage prebacujem se na široki prozor radi slobodnog zraka.
- [ ] Mogu snimiti standardne presjeke UZV-a desnog gornjeg kvadranta.
- [ ] Poznajem put hitne prijave kod akutnog abdomena.
- [ ] Usporedio/la sam najmanje 15 CT-a abdomena s opisom svojeg mentora.
- [ ] Pročitao/la sam dio o abdomenu u Svesku 03 · CT i dio o desnom gornjem kvadrantu u Svesku 05 · UZV/POCUS.

ROTACIJA 4

Mišićno-koštana radiologija

Traumatološke snimke, MR zglobova i koštane lezije. Tko ne gleda sustavno, propustit će i najlakši prijelom.

Što trebate znati prvi dan

- **Kod svake RTG snimke kod traume najmanje dvije okomite ravnine** potrebne i ne zaboravite da jedna ravnina može prikriti prijelom.
- Redoslijed očitavanja RTG snimke kostiju: cjelovitost korteksa, poravnanje zgloba, zglobni prostor, koštano tkivo (denzitet i struktura), meko tkivo (oteklina, masni jastučići, zrak).
- Naučite redoslijed opisa frakture: kost i regija, smjer linije frakture, broj fragmenata, pomak i angulacija, zahvaćenost zgloba.
- Naučite osnovne sekvencije na MR-u zglobova (PD/T2 sa supresijom masti, T1) i koja se struktura najbolje vidi na kojoj sekvenciji.
- Sustavni pristup koštanoj leziji: lokalizacija, ograničenje (prijelazna zona), periostalna reakcija, matriks, mekotkivna komponenta.

10 najčešćih pretraga

#	PRETRAGA	PRVO ŠTO TREBA POGLEDATI
1	**RTG ručnog zgloba**	Distalni radijus, skafoid, raspored karpalnih kostiju.
2	**RTG gležnja**	Maleoli, prostor gležanjske vilice, talus.
3	**RTG kuka i zdjelice**	Korteks vrata femura, cjelovitost zdjeličnog prstena.
4	**RTG ramena**	Odnos glave humerusa i glenoida, fraktura, iščašenje.
5	**RTG koljena**	Tibijalni plato, izljev, zglobna pukotina.
6	**MR koljena**	Menisci, ukrižene sveze, edem koštane srži, hrskavica.
7	**MR ramena**	Tetive rotatorne manšete, labrum, tetiva bicepsa.
8	**Traumatološki CT (zdjelica, kralježnica, intraartikularni prijelom)**	Pružanje linije frakture, broj fragmenata, zglobna ploha.
9	**RTG lumbalne / torakalne kralježnice**	Visina kralješka, poravnanje, cjelovitost pedikula.
10	**Procjena koštane lezije (RTG, CT ili MR)**	Prijelazna zona, periostalna reakcija, matriks, mekotkivna komponenta.

Tipične pogreške

- Pronaći jedan prijelom i **drugi prijelom** ili ne tražiti pridruženu luksaciju.
- Poput skafoida i vrata femura **kod prijeloma koji mogu ostati skriveni** ne pomisliti na preporuku dodatne pretrage ili praćenja ako je snimka normalna.

- Ne procijeniti nalaze mekih tkiva (znak masnog jastučića, izljev u zglobu).
- Na RTG snimci ramena previdjeti stražnje iščašenje na jednoj ravnini.
- Koštanu leziju ostaviti na jednoj riječi («litička») bez sustavnog opisa.

Kontrolni popis za prvi tjedan

- [ ] Kod svake RTG snimke kod traume provjeravam dvije ravnine.
- [ ] Primjenjujem redoslijed očitavanja RTG snimke kostiju (korteks, poravnanje, zglob, kost, meko tkivo).
- [ ] Frakturu mogu opisati redoslijedom koji odjel očekuje.
- [ ] Na MR-u koljena mogu procijeniti menisk i ukrižene sveze sekvenciju po sekvenciju.
- [ ] Sustavni pristup koštanoj leziji primijenio/la sam na jednom slučaju od početka do kraja.
- [ ] Usporedio/la sam najmanje 30 RTG snimki kod traume s opisom specijalista.
- [ ] Pregledao/la sam mišićno-koštani dio Sveska 02 · RTG i pripadajući kontrolni popis u Vodiču za interpretaciju snimki.

ROTACIJA 5

Pedijatrijska radiologija

Dijete nije mala odrasla osoba: drugačija anatomija, drugačije bolesti i veća pažnja prema zračenju.

Što trebate znati prvi dan

- **Načelo zaštite od zračenja** ima prednost u djece: ako je moguće, prednost se daje metodi bez zračenja (UZV, MR); ako je CT potreban, koristi se pedijatrijski protokol odjela.
- Ploče rasta, osifikacijske jezgre i normalan izgled koji se mijenja s dobi mogu se zamijeniti s frakturom; u slučaju dvojbe **usporedba sa suprotnom stranom** i uporaba atlasa procjenjuju se prema praksi odjela.
- Znajte za široku primjenu UZV-a u pedijatriji: npr. invaginacija, apendicitis, pilorus, kukovi i kranijalni UZV.
- Kad u djeteta vidite neobjašnjiv prijelom, prijelome u različitim stadijima ili nalaze koji ne odgovaraju anamnezi, na odjelu **postupak prijave radi zaštite djeteta** pratite zajedno s Vašim mentorom.
- Naučite kako na odjelu funkcioniraju pretrage koje zahtijevaju sedaciju i pripremu.

10 najčešćih pretraga

#	PRETRAGA	PRVO ŠTO TREBA POGLEDATI
1	**RTG prsnog koša u djeteta**	Tehnika, sjena timusa, konsolidacija, zarobljavanje zraka, strano tijelo.
2	**UZV abdomena (bol u trbuhu)**	Apendiks, invaginacija, slobodna tekućina, limfni čvorovi.
3	**RTG lakta**	Masni jastučići, osifikacijske jezgre, suprakondilarni prijelom.
4	**RTG podlaktice i ručnog zgloba**	Torus prijelomi i prijelomi tipa zelene grančice, ploča rasta.
5	**UZV kukova (dojenče)**	Odnos acetabuluma i glave femura, metoda mjerenja na odjelu.
6	**UZV mokraćnog sustava**	Hidronefroza, veličina bubrega, stijenka mokraćnog mjehura.
7	**Kranijalni UZV (novorođenče)**	Veličina ventrikula, krvarenje, ehogenost parenhima.
8	**UZV pilorusa**	Debljina mišića pilorusa i duljina kanala (prema kriterijima odjela).
9	**Nativna snimka abdomena**	Raspodjela crijevnog plina, opstrukcija, strano tijelo.
10	**CT mozga bez kontrasta (trauma)**	Krvarenje, fraktura; usklađenost indikacije s pravilima odjela.

Tipične pogreške

- Normalnu ploču rasta ili osifikacijsku jezgru **smatrati prijelomom**, ili obrnuto.
- Vidjeti znak masnog jastučića na RTG snimci lakta i ne pomisliti na okultnu frakturu.
- Normalnu sjenu timusa protumačiti kao medijastinalnu masu.
- Refleksno predlagati CT za pitanje na koje se može odgovoriti UZV-om.

- Samo opisati nalaz koji ne odgovara dobi ili anamnezi i ne pomisliti na postupak prijave.

Kontrolni popis za prvi tjedan

- [ ] Poznajem pedijatrijski CT protokol odjela i pravila zaštite od zračenja.
- [ ] Na RTG snimci lakta mogu procijeniti redoslijed osifikacijskih jezgri i masne jastučiće.
- [ ] Mogu opisati torus prijelome, prijelome tipa zelene grančice i prijelome ploče rasta.
- [ ] Barem sam nekoliko puta prisustvovao/la UZV-u abdomena zbog apendiksa i invaginacije.
- [ ] Postupak prijave radi zaštite djeteta naučio sam od svojeg mentora.
- [ ] Vidio/la sam primjere normalnog timusa, normalne ploče rasta i normalnih varijanti.
- [ ] Pregledao/la sam pripadajuće dijelove Sveska 05 · UZV/POCUS i Sveska 02 · RTG.

ROTACIJA 6

Intervencijska radiologija i dojka

Dva različita svijeta, jedno zajedničko pravilo: priprema prije zahvata i opisivanje slike ispravnim jezikom.

Što trebate znati prvi dan

INTERVENCIJSKA RADIOLOGIJA

- Kontrola prije zahvata: indikacija, prethodne snimke, pristanak, laboratorijski nalazi i lijekovi koje odjel traži (odluku donosi Vaš mentor).
- Pravila sterilnog polja, zaštita od zračenja (olovna pregača, štitnik za štitnjaču, udaljenost, vrijeme) i uporaba dozimetra.
- Upoznajte najčešće zahvate: biopsija pod kontrolom UZV-a ili CT-a, drenaža apscesa i tekućine, perkutana nefrostomija, centralni venski pristup, angiografija.
- Za praćenje bolesnika nakon zahvata naučite kontrolni popis odjela.

RADIOLOGIJA DOJKE

- Upoznajte standardne mamografske snimke (CC i MLO); obje dojke uspoređujte simetrično.
- U opisu **standardni klasifikacijski sustav** i naučite terminologiju koju koristi Vaš odjel; kategoriju i preporuku pišite zajedno.
- Znajte osnovna obilježja koja na UZV-u dojke razlikuju cistu od solidne lezije: oblik, ograničenje, unutarnja struktura, stražnja akustična obilježja.
- Usporedba s prethodnim mamografijama posebno je važna u radiologiji dojke.

10 najčešćih pretraga i zahvata

#	PRETRAGA / ZAHVAT	PRVO ŠTO TREBA POGLEDATI
1	**Probirna mamografija**	Simetrija, tvorba, kalcifikacije, distorzija arhitekture; usporedba s prethodnom pretragom.
2	**Dijagnostička mamografija**	Lokalizacija kliničkog nalaza; potreba za dodatnim snimanjem.
3	**UZV dojke**	Cista ili solidna lezija; oblik, ograničenje, orijentacija, stražnja akustična obilježja.
4	**Biopsija dojke pod kontrolom UZV-a**	Ciljna lezija, put igle, primjerenost uzorka.
5	**Biopsija štitnjače ili limfnog čvora pod kontrolom UZV-a**	Cilj, okolne krvne žile, siguran put.
6	**Biopsija pod kontrolom CT-a**	Cilj i siguran put igle; odnos s pleurom i krvnim žilama.
7	**Drenaža apscesa / tekućine**	Veličina kolekcije, sadržaj, siguran put pristupa.
8	**Perkutana nefrostomija**	Stupanj hidronefroze, put pristupa bubregu.

#	PRETRAGA / ZAHVAT	PRVO ŠTO TREBA POGLEDATI
9	**Središnji venski pristup / port**	Prohodnost krvne žile (UZV), položaj vrha (skopija ili RTG snimka).
10	**Dijagnostička angiografija**	Mjesto pristupa, anatomija krvnih žila, stenoza ili izvor krvarenja.

Tipične pogreške

- Ući u zahvat bez pregleda prethodnih snimki.
- Zanemariti opremu za zaštitu od zračenja i dozimetar.
- Na mamografiji pregledati samo jednu dojku i **usporedba simetrije** ne napraviti.
- U opisu dojke navesti kategoriju, a ne napisati jasnu preporuku.
- U bilješci o zahvatu ne navesti primijenjenu metodu, broj uzoraka i je li bilo komplikacija.

Kontrolni popis za prvi tjedan

- [ ] Poznajem kontrolni popis odjela prije zahvata i pridržavam ga se.
- [ ] Pri svakom zahvatu koristim svoju opremu za zaštitu od zračenja i dozimetar.
- [ ] Prisustvovao/la sam najmanje 3 zahvata pod kontrolom UZV-a i zabilježio/la njihove korake.
- [ ] Prepoznajem CC i MLO snimke i simetrično uspoređujem obje dojke.
- [ ] Naučio/la sam standardne kategorije i preporuke u opisu dojke.
- [ ] Na UZV-u dojke mogu opisati cistu i solidnu leziju.
- [ ] Pregledao/la sam Svezak 05 · UZV/POCUS i pripadajuće slučajeve u Svesku 06 · Multimodalni slučajevi.

ZAVRŠETAK

Posljednji dan svake rotacije

Pri prijelazu s jedne rotacije na drugu, završni pregled od 20 minuta učvršćuje ono što ste naučili.

1. **Vratite se na kontrolni popis.** Stavke koje niste mogli označiti zapišite za prvi tjedan sljedeće rotacije.
2. **5 pretraga koje Vam zadaju najviše poteškoća** Zapišite u Radnu bilježnicu: što ste propustili, zašto ste to propustili i što ćete sljedeći put učiniti.
3. **Zamolite Vašeg mentora za kratku povratnu informaciju:** «Što bih na ovoj rotaciji trebao raditi bolje?»
4. **Poglavlje sljedeće rotacije** pročitajte jednom u ovom vodiču.
5. **u 12-tjednom programu učenja za rotacije** prilagodite sljedeći tjedan svojoj novoj rotaciji.

> **Zlatno pravilo**
>
> Na svakoj rotaciji postavite si isto pitanje: «Mogu li na dežurstvu sam/a i sigurno očitati pretragu iz ovog područja?» Ako je odgovor «još ne», ono što nedostaje dodajte na kontrolni popis.

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Sada otvorite poglavlje svoje trenutačne rotacije i ispišite kontrolni popis za prvi tjedan.

Zatim **Predlošci za prezentaciju slučaja na viziti**: prijeđite na njega – ondje ćete pronaći kako slučajeve koje vidite na rotaciji predstaviti na viziti za 60 ili 120 sekundi.